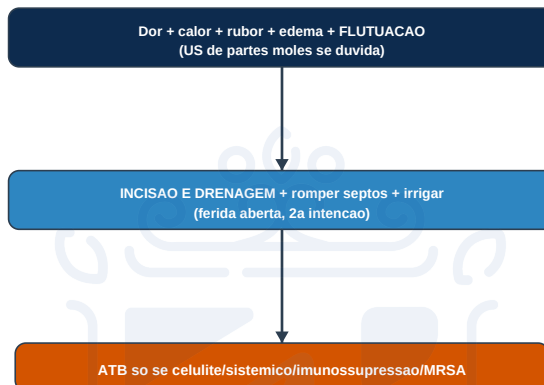


ABSCESO CUTÂNEO — INCISÃO E DRENAGEM

FLUXOGRAMA — ABORDAGEM

ABSCESO CUTÂNEO — FLUTUAÇÃO -> DRENAR



DEFINIÇÃO E INDICAÇÕES

DRENAGEM É O TRATAMENTO

- Coleção localizada de pus na pele/subcutâneo; dor, calor, rubor, edema e FLUTUAÇÃO
- Indicar drenagem: flutuação (pus), falha do ATB isolado, abscesso > 2 cm/sintomático, celulite extensa/febre/linfangite, risco anatômico (perianal, facial, mãos)
- Não há contraindicação absoluta quando há indicação clara
- Contraindicações relativas: proximidade de grandes vasos/nervos, anatomia incerta (-> drenagem cirúrgica especializada), coagulopatia grave (corrigir antes)
- US de partes moles confirma coleção e guia drenagem profunda/complexa; labs/cultura se sinais sistêmicos, recorrência ou imunossupressão

TÉCNICA DE INCISÃO E DRENAGEM

Rx PASSO A PASSO

EPI + assepsia (clorexidina/iodopovidona); campo estéril
Anestesia local com lidocaína ao redor do abscesso (evitar injetar dentro da coleção)
Incisão linear de 1-2 cm sobre o ponto de máxima flutuação
Explorar a cavidade com pinça curva, ROMPER os septos internos para drenagem completa
Irigar a cavidade com SF estéril; em abscessos grandes/profundos, colocar dreno (Penrose/loop)
NÃO suturar — manter a ferida ABERTA (cicatrização por 2ª intenção); curativo estéril

MEDICAÇÕES

Rx ANALGESIA ± ATB

Analgesia: Paracetamol 500 mg 6/6h ou Cetoprofeno 100 mg 8/8h por ~5 dias
ATB NÃO é necessário no abscesso simples drenado, sem sinais sistêmicos
ATB adjuvante se: celulite extensa/febre, imunossupressão, suspeita de MRSA, abscesso facial/perianal
Opções empíricas (cobrir MRSA comunitário): SMX-TMP 160/800 mg 12/12h; ou Clindamicina 300 mg 8/8h; ou Doxiciclina
Duração 5-10 dias, conforme evolução

PÓS-PROCEDIMENTO, ALERTA E SITUAÇÕES ESPECIAIS

CUIDADOS

- Reavaliar em 24-48h; troca diária de curativo mantendo a ferida aberta; compressas mornas ajudam
- Sinais de alerta (retorno imediato): aumento da dor/rubor, secreção fétida, febre persistente, linfangite
- Abscesso FACIAL: risco de trombose do seio cavernoso — manejo cuidadoso + ATB
- Perianal ou próximo a vasos/nervos: considerar drenagem cirúrgica especializada
- Diabético/imunossuprimido: maior risco — ATB frequentemente indicado; vigiar evolução para fasciíte necrotizante

MODELO DE ALTA / ENCAMINHAMENTO

RESUMO PARA ALTA

- Paciente ____ anos com abscesso cutâneo em ____; drenado por incisão + irrigação; dreno: sim/não.
- Sinais sistêmicos/celulite ____; comorbidade (DM/imunossupressão) ____.
- Prescrição: analgesia ____; ATB ____ (se indicado); curativo diário, ferida aberta.
- Retorno em 48h; sinais de alerta orientados; encaminhar cirurgia se perianal/recorrente/complexo.

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Qual é o tratamento definitivo de um abscesso cutâneo flutuante?

- A) Antibiótico oral isolado
- B) Incisão e drenagem, com ruptura de septos e irrigação, mantendo a ferida aberta
- C) Compressas mornas apenas
- D) Corticoide
- E) Observação

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Quando o antibiótico é adjuvante após drenagem de abscesso cutâneo?

- A) Sempre, em todos os casos
- B) Celulite extensa/febre, imunossupressão, suspeita de MRSA ou localização de risco (facial/perianal)
- C) Nunca
- D) Apenas se o abscesso for < 1 cm
- E) Somente se houver dreno

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Por que a ferida do abscesso drenado não deve ser suturada?

- A) Para acelerar a cicatrização primária
- B) Para permitir a drenagem contínua e a cicatrização por segunda intenção, evitando recoleção
- C) Por questão estética
- D) Porque a sutura é proibida em qualquer ferida
- E) Para reduzir o custo

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Qual antibiótico empírico cobre adequadamente MRSA comunitário em abscesso cutâneo?

- A) Amoxicilina isolada
- B) SMX-TMP, clindamicina ou doxiciclina
- C) Penicilina cristalina
- D) Cefalexina isolada
- E) Azitromicina

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Por que o abscesso facial merece atenção especial?

- A) Risco de trombose do seio cavernoso
- B) Risco de litíase
- C) Risco de hérnia
- D) Risco de pancreatite
- E) Não tem relevância

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

O tratamento definitivo do abscesso flutuante é a incisão e drenagem, com ruptura dos septos e irrigação, mantendo a ferida aberta para cicatrização por segunda intenção.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

O ATB é adjuvante quando há celulite extensa/febre, imunossupressão, suspeita de MRSA ou localização de risco (facial/perianal); no abscesso simples drenado e sem sinais sistêmicos, a drenagem basta.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Não se sutura para permitir a drenagem contínua e a cicatrização por segunda intenção, evitando a recoleção do pus.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

SMX-TMP, clindamicina e doxiciclina cobrem MRSA comunitário; são as opções empíricas quando se indica ATB adjuvante.

QUESTÃO 5 → Resposta: A

Abscessos faciais (sobretudo no triângulo perinasal) têm risco de trombose do seio cavernoso por drenagem venosa, exigindo manejo cuidadoso e antibiótico.

SM24
Suporte ao Plantão Médico